★★★骨与关节感染（0~6题）

化脓性感染

儿童多见
急性起病、寒战高热
关节附近疼痛、血 WBC ↑
金葡菌为主
（2007、2018）

- 明显深压痛→急性骨髓炎（2017、2022）
  - 好发于膝关节上下干骺端（2011、2017）
  - 早期诊断：MRI（首选）、脓肿分层穿刺涂片（最佳）（2017、2022）
  - 早期、足量、联合、全程用抗生素：一种针对 G+ 球菌、一种为广谱
  - 早期手术：钻孔灌洗、或开窗减压引流（2022）
- 明显肿胀或浮髌试验（膝关节）→急性关节炎（2024）
  - 好发于髋＞膝关节（2009）
  - 早期诊断：关节穿刺（2018）
  - 全身用抗生素
    关节腔注射抗生素、或置管持续灌洗（膝关节），若无效或已化脓关节镜手术（2024）

病程长、窦道排出死骨→慢性骨髓炎（2015、2020）

- 手术为主
  - ①病灶清除术：摘除死骨（大块死骨需等包壳充分形成后再手术），切除坏死 / 肉芽 / 瘢痕组织、窦道等
  - ②消灭死腔：碟形 /Orr 手术、肌瓣或抗生素骨水泥填塞
  - ③冲洗引流、病段切除、闭合伤口
- 急性发作：抗生素、积脓时切开引流，不做病灶清除术

结核（2014）

- 概述（2024）
  - 发病率：脊柱结核＞膝关节结核＞髋关节结核“鸡西宽冷面”（2025）
  - 椎体或关节破坏、椎间隙或关节间隙狭窄
    寒性 / 冷脓肿：多无红、热，如脊柱寒性脓肿可见椎旁软组织影和腰大肌影增宽，尽量不切开引流（2014、2019、2026）
  - MRI（2017、2018、2026）
  - 抗结核治疗为主
  - 有指征且无禁忌症再手术（2017）
    - 抗结核 2~4 周→手术→抗结核≥ 12 个月
    - 禁忌症：全身中毒症状明显、或伴其他脏器活动期结核
- 脊柱结核（2015、2018、2019、2026）
  - ①腰椎结核（最常见）：成人、边缘型、拾物试验多见
  - ②胸椎结核：儿童、中心型（椎间隙多正常）、后凸畸形和截瘫多见
  - 病灶清除术的指征：抗结核治疗无缓解、脊髓或马尾神经受压、脊柱不稳定、严重后凸畸形、较大死骨及寒性脓肿、或窦道经久不愈
- 髋关节结核（2017）
  - 儿童和青少年多见
  - 4 字试验、髋关节过伸试验、髋关节屈曲挛缩试验 /Thomas 征“能屈能伸能死”（2011）